

TEMA 3.12 • ENDOCRINOLOGÍA

Amenorrea

PERFIL EUNACOM 1.03.3.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Amenorrea

Definición

- **Primaria:** nunca ha menstruado y tiene ≥ 16 años (o ≥ 14 sin caracteres sexuales secundarios)
- **Secundaria:** ausencia de menstruación > 3 meses en mujer que antes menstruaba

Primer paso siempre: descartar embarazo

> β-hCG antes de cualquier otro estudio

Amenorrea Primaria

Causas y evaluación

- Examinar caracteres sexuales secundarios (mamas, vello) y genitales
- Si **no hay útero** → pensar en **Síndrome de Mayer-Rokitansky** (agenesia vaginal/uterina, cariotipo 46XX) o **Síndrome de Morris** (resistencia a andrógenos, cariotipo 46XY, fenotipo femenino)
- Si **hay útero pero no menarquia** → evaluar nivel del bloqueo (ver algoritmo secundaria)

Amenorrea Secundaria

Algoritmo por FSH y LH

TABLA 3.12.1: FSH/LH VS ESTRÓGENOS		
FSH/LH	ESTRÓGENOS	DIAGNÓSTICO
↑↑	↓	Falla ovárica primaria (menopausia precoz, Sx Turner)
Normal o ↓	Normal o ↓	Causa hipotalámica o hipofisaria

Causas hipotalámicas frecuentes

- Estrés, anorexia, ejercicio excesivo → ↓ GnRH
- **Síndrome de ovario poliquístico (SOP/PCOS):** la más frecuente de amenorrea secundaria; TSH normal; ↑ LH / FSH normal → ↑ andrógenos → oligomenorrea/amenorrea + acné + hirsutismo

Causas hipofisarias

- **Prolactinoma** (↑ prolactina → inhibición de GnRH) → galactorrea + amenorrea - **Síndrome de Sheehan** (infarto hipofisario post-parto)

Causas uterinas

- **Síndrome de Asherman:** sinequias uterinas post-legrado o endometritis → amenorrea secundaria estructural

Resumen de Diagnóstico diferencial

TABLA 3.12.2: CAUSA VS CLÍNICA DIFERENCIADORA		
CAUSA	CLÍNICA DIFERENCIADORA	EXAMEN CLAVE
SOP	Irregular + androgenismo	Ecografía (ovarios poliquísticos) + LH/FSH
Prolactinoma	Galactorrea + ↑ prolactina	Prolactina + RNM hipofisaria
Sheehan	Post-hemorragia puerperal	Perfil hormonal completo
Falla ovárica	↑ FSH + signos de menopausia	FSH

| Asherman | Post-legrado | Histeroscopia |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 35 años con amenorrea de 4 meses. Exámenes: estradiol bajo, FSH 65 mU/mL (elevada), LH 50 mU/mL (elevada), hormona antimülleriana baja, hCG negativa. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amenorrea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amenorrea secundaria: ausencia de menstruación ≥3 ciclos regulares o >90 días si irregulares.
- SIEMPRE descartar embarazo primero, independientemente de lo que diga la paciente.
- Estudio actual: estradiol, progesterona, FSH/LH, prolactina, TSH, hCG, hormona antimülleriana.
- Estradiol bajo + FSH/LH alta = hipogonadismo hipergonadotrópico (falla ovárica). <40 años = menopausia precoz.
- Estradiol bajo + FSH/LH baja = hipogonadismo hipogonadotrópico (hipotalámico-hipofisario).
- Todo normal + no embarazada = causa uterina (síndrome de Asherman).
- Estradiol normal + progesterona baja + LH alta = anovulación (SOP).
- Amenorrea primaria: sin menarquia a los 15 años con pubertad, o 13 años sin pubertad.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMENORREA)

PREGUNTA 1

Mujer de 35 años con amenorrea de 4 meses. Exámenes: estradiol bajo, FSH 65 mU/mL (elevada), LH 50 mU/mL (elevada), hormona antimülleriana baja, hCG negativa. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de ovario poliquístico

B) Menopausia precoz (falla ovárica prematura)

C) Síndrome de Sheehan

D) Síndrome de Asherman

E) Hiperprolactinemia

RESUMEN: AMENORREA

La amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación por ≥ 3 ciclos regulares o >90 días si irregulares. Causas fisiológicas: embarazo, lactancia, menopausia. Causas patológicas: hormonales y anatómicas. El estudio clásico (obsoleto pero útil para fisiopatología) usa prueba de progesterona (positiva = anovulación/SOP) y prueba de estrógeno+progesterona (positiva = hipogonadismo, negativa = causa uterina). El estudio actual pide todos los exámenes juntos: estradiol, progesterona, FSH/LH, prolactina, TSH, hCG, hormona antimülleriana (reflejo de reserva ovárica). Interpretación: estradiol bajo + FSH/LH alta = hipogonadismo hipergonadotrópico (falla ovárica, si <40 años = menopausia precoz). Estradiol bajo + FSH/LH baja = hipogonadismo hipogonadotrópico (causa hipotalámico-hipofisiaria). Todo normal + no embarazada = causa uterina (ej. síndrome de Asherman). Estradiol normal + progesterona baja + LH alta = anovulación (SOP). Amenorrea primaria: ausencia de menarquia a los 15 años con desarrollo puberal o 13 años sin desarrollo puberal.